

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA



FACULTAD DE MEDICINA HUMANA

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA

**FACTORES ASOCIADOS A ESTILO DE VIDA EN MUJERES EN EDAD
FÉRTIL EN EL CENTRO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, 2024.**

PROYECTO DE TESIS

Para optar el título profesional de Médico (a) Cirujano (a)

AUTORA

PALOMINO RIVERA, NICOLE CAMILA
Orcid: 0009-0002-1888-6252

ASESORA

Mg. VILCA VARGAS, MARIELA
Orcid: 0000-0002-9155-9904

COASESOR

MC. WALTER ZAPATA ACHA

Lima, Perú

2024

ÍNDICE

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

- 1.1 Descripción de la realidad problemática
- 1.2 Formulación del problema
- 1.3 Línea de investigación
- 1.4 Objetivos: General y Específicos.
- 1.4 Justificación
- 1.5 Limitaciones
- 1.6 Viabilidad

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

- 2.1 Antecedentes de la investigación Internacional y Nacional
- 2.2 Bases teóricas
- 2.3 Definiciones conceptuales
- 2.4 Hipótesis

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

- 3.1 Diseño
- 3.2 Población y muestra
- 3.3 Operacionalización de variables
- 3.4 Técnicas de recolección de datos. Instrumentos
- 3.5 Técnicas para el procesamiento de la información
- 3.6 Aspectos éticos

CAPÍTULO IV

RECURSOS Y CRONOGRAMA

4.1 Recursos

4.2 Cronograma

4.3 Presupuesto

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANEXOS

1. Matriz de consistencia
2. Instrumentos de recolección de datos
3. Documento de aprobación del proyecto por parte del INICIB/Consejo de Facultad.
4. Consentimiento informado (En caso de aplicar)
5. Reporte de Turnitin (Mínimo <25%, Ideal: <10%)
6. Otros anexos

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripción de la realidad problemática

Las mujeres en edad fértil (MEF) representan un grupo clave en la salud pública, ya que sus características de salud y estilo de vida influyen tanto en su propio bienestar como en la salud de las futuras generaciones.¹ Según la Organización Mundial de la Salud, la etapa reproductiva de la mujer abarca de los 15 a los 49 años, y en este grupo etario es crucial abordar los estilos de vida y los factores asociados para prevenir enfermedades y promover la salud a nivel global.²

Las MEF con estilos de vida inadecuados están en riesgo de desarrollar condiciones como el sobrepeso y la obesidad, que son responsables del 90 % de los casos de diabetes mellitus tipo 2, además de otras enfermedades crónicas no transmisibles como dislipidemia, enfermedades coronarias, accidentes cerebrovasculares, apnea del sueño y osteoartritis.³ Estas condiciones no solo comprometen la salud actual de las mujeres, sino también su capacidad de llevar una maternidad saludable.

Es relevante considerar que muchas mujeres desde edades tempranas están expuestas a enfermedades de transmisión sexual, las cuales constituyen riesgos no solo físicos para la salud, sino también psicológicos y estas condiciones pueden afectar negativamente la salud reproductiva y la maternidad, vinculadas a estilos de vida poco saludables, creencias, actitudes y prácticas perjudiciales tanto para la salud individual como para la salud familiar y comunitaria.⁴

En el Perú, según la Encuesta Nacional de 2017 realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), existen 7 845 787 MEF de entre 15 y 49 años a nivel nacional, de las cuales 2 427 490 residen en Lima Metropolitana.⁵ De ellas, muchas forman parte de la población económicamente activa, un factor que influye directamente en los estilos de vida, ya que el desempleo se ha asociado con efectos negativos sobre la salud, como el aumento del riesgo de enfermedades crónicas (cardiovasculares, diabetes) y mentales (depresión, ansiedad).⁶ La falta de acceso a servicios de salud adecuados, debido a la pérdida de seguro médico, puede empeorar aún más el estado de salud de estas mujeres.⁷

Es fundamental priorizar la salud y bienestar de las MEF, dado que un estilo de vida activo y saludable mejora no solo su calidad de vida, sino también las condiciones para una maternidad saludable, reduciendo la mortalidad materna; es así, que el estilo de vida y la calidad de vida percibida por el individuo son determinantes críticos en la salud reproductiva.⁸

Por lo tanto, es crucial identificar los factores que influyen en que las MEF adopten estilos de vida no saludables, lo que podría conducir a la aparición de enfermedades a corto y largo plazo, así como la prevención y promoción de la salud deben enfocarse en modificar estos factores, asegurando un futuro más saludable para las mujeres y las generaciones venideras.

En el Centro de Salud Enrique Montenegro, ubicado en San Juan de Lurigancho y perteneciente a la jurisdicción de la Dirección de Salud Lima Centro, se atienden aproximadamente 35 MEF en el consultorio de medicina por día. Este centro de salud, clasificado como establecimiento de nivel I-3, es un entorno adecuado para identificar los factores que inciden en los estilos de vida inadecuados de las mujeres que acuden al servicio. Aquí se debe hacer un esfuerzo especial en la promoción y prevención de la salud desde la atención primaria, pues al ser el primer nivel de

atención, se tiene la oportunidad de intervenir en los factores que contribuyen a un estilo de vida no saludable, promoviendo así mejores condiciones de salud para estas mujeres y sus futuras generaciones.

1.2 Formulación del problema

¿Cuáles son los factores sociodemográficos y económicos asociados a estilo de vida en mujeres en edad fértil en el Centro de Salud Enrique Montenegro en diciembre 2024?

1.3 Línea de investigación

El presente estudio toma como línea de investigación a la onceava prioridad nacional de investigación en salud 2019-2023: medicina del estilo de vida, medicina preventiva y salud pública.

1.4 Objetivos: General y Específicos.

OBJETIVO GENERAL:

Determinar los factores sociodemográficos y económicos asociados a estilo de vida en mujeres de edad fértil (MEF) en el Centro de Salud Enrique Montenegro en diciembre 2024.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Identificar las características sociodemográficas de las MEF en el CSM, en diciembre 2024.
- Identificar la frecuencia de los niveles de estilo de vida en MEF en el Centro de Salud Montenegro en diciembre 2024.
- Determinar la asociación entre los factores sociodemográficos y el estilo de vida en MEF en el Centro de Salud Enrique Montenegro en diciembre 2024.
- Determinar la asociación entre los factores económicos y el estilo de vida en MEF en diciembre 2024.

1.5 Justificación

En el Perú, según los datos demográficos, el 52% de las mujeres, es decir, aproximadamente 8.8 millones, están en edad fértil, mientras que un 23.5% son menores de 15 años.⁹ Dentro de este grupo en edad fértil, se encuentran mujeres económicamente activas, adolescentes con alta probabilidad de fecundidad, madres de familia, entre otras. Estas mujeres enfrentan una serie de factores que influyen en sus estilos de vida, los cuales son determinantes para la adopción de hábitos saludables. La modificación de comportamientos individuales poco saludables es esencial, ya que estos hábitos no solo impactan en su salud personal, sino también en su responsabilidad social y moral.¹⁰

Las mujeres a menudo perciben su salud como una consecuencia directa de sus elecciones de estilo de vida, las cuales consideran bajo su control y libres de presiones externas; sin embargo, es esencial identificar las barreras y factores negativos que influyen en sus decisiones de salud. Esta información permitirá guiar a las mujeres hacia la implementación de prácticas saludables, considerando factores económicos, familiares y socioculturales. De esta forma, se podrá prevenir

la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles, como dislipidemia, diabetes y hipertensión arterial, las cuales se relacionan con estilos de vida inadecuados y malos hábitos que no solo afectan a las mujeres, sino también a las futuras generaciones, especialmente en el caso de mujeres gestantes.¹¹

Esta investigación será clave para mejorar las estrategias de salud pública dirigidas a informar sobre los factores modificables y no modificables que influyen en la calidad de vida y en la adopción de hábitos saludables. Al concienciar a las mujeres en edad fértil sobre la importancia de un estilo de vida adecuado, se busca fomentar una prevención efectiva y una promoción de la salud más robusta. Además, mejorar los estilos de vida contribuirá a reducir la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, garantizando una mejor calidad de vida en el futuro.

1.6 Limitaciones

La aplicación del instrumento se realizará únicamente dentro del Centro de Salud Enrique Montenegro en San Juan de Lurigancho, por lo que los hallazgos solo aplican para la población de mujeres en edad fértil del puesto de Salud.

Mujeres en edad fértil que no hayan sido diagnosticadas o tengan enfermedades subclínicas o alguna enfermedad de salud mental que no sea reportada por vergüenza a pesar de que se indica que el cuestionario aplicado será de manera anónima.

1.7 Viabilidad

El proyecto cuenta con viabilidad y el acceso del Centro de Salud Enrique Montenegro en San Juan de Lurigancho y hay disposición en cuanto a los recursos económicos para ejecutar el estudio del proyecto.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la investigación Internacional y Nacional

ANTECEDENTES NACIONALES

Anny Fabiola Chiroque, Juárez Alfonso Gutiérrez, Rubén Espinoza en el año 2018 en su estudio “Estilos de vida en mujeres de 18 a 49 años con sobrepeso y obesidad del Perú: análisis de la ENDES 2018” estudio observacional, transversal, analítico, data secundaria de ENDES 2018 se determinó la asociación entre estilos de vida en mujeres de 18 a 49 años con sobrepeso y obesidad del Perú, donde se obtuvo que la prevalencia de sobrepeso fue 41,4% y obesidad 22,7% y en el análisis multivariado, los factores sociodemográficos tienen asociación significativa con obesidad: área urbana, índice de riqueza estilos de vida como: consumo de alcohol, frecuencia de ver televisión. Llegando a la conclusión de tanto para sobrepeso como obesidad se encontró asociación significativa con el índice de riqueza. Además, para obesidad se encontró que el

consumo de frutas presenta un factor protector; en cambio, residir en área urbana, consumir bebidas alcohólicas y la frecuencia de ver televisión son factores de riesgo.¹²

Zapata García, Tania Shiomara en el año 2019, en su estudio titulado “Factores sociodemográficos y acciones de prevención y promoción asociado al comportamiento de la salud: estilos de vida de la mujer adulta joven. Pueblo joven Miramar Alto, sector I-Chimbote, 2019” dónde se realizó un estudio en una muestra de 100 mujeres adultas jóvenes, dónde se utilizó la técnica de entrevista; llegando a la conclusión que en los factores sociodemográficos más de la mitad tienen grado de instrucción superior y sistema de seguridad SIS; la mitad son solteras, menos de la mitad san la religión católica, ingreso económico de s/. 400 a 650 nuevos soles y otras ocupaciones. En acciones de prevención y promoción, más de la mitad tiene un nivel adecuado y menos de la mitad nivel inadecuado. En los estilos de vida, más de la mitad san saludable y menos de la mitad no saludable. Al realizar la prueba de Chi Cuadrado entre factores sociodemográficos asociados al estilo de la vida si existe relación entre las variables. En acciones de prevención y promoción asociado al estilo de vida si relación existe entre las variables.¹³

Quillas Benites R, Vásquez Valencia C, Cuba Fuentes M en su estudio realizado en el año 2017 titulado “Promoción de cambios de comportamiento hacia estilos de vida saludable en la consulta ambulatoria” dónde se concluyó que las personas que practican hábitos nocivos para su salud dónde se debe identificar en qué etapa de cambio se encuentran para así aplicar las estrategias adecuadas de acuerdo a la etapa en la que se encuentre, por lo que es necesario que estemos preparados para poder ayudar a nuestros pacientes a determinarse a cambiar y para ello podemos usar dos herramientas eficaces como la Motivación para el Cambio de Comportamiento de Prochaska y la Entrevista Motivacional de Miller las cuales hasta ahora en la práctica médica tienen resultados satisfactorios.¹⁴

Meléndez-Asipali Josué A., Espinoza Rubén, Rivadeneyra-Romero Rosa, Vela-Ruiz José M., De La Cruz-Vargas Jhony A. En Perú en el año 2022 en su estudio denominado “Factores asociados al uso de métodos anticonceptivos en mujeres en edad fértil de 15 a 49 años según encuesta demográfica en Perú”, cuyo estudio fue descriptivo, observacional, analítico y retrospectivo. Se analizó la muestra de la Encuesta Nacional Demográfica de Salud Familiar (ENDES), del año 2018 a mujeres peruanas entre 15 a 49 años que respondieron el módulo de métodos anticonceptivos, dónde la mayor prevalencia de usuarias de métodos anticonceptivos fue en el área urbana ,según estado conyugal se evidencia un mayor uso en casadas o convivientes , en el nivel educativo se obtuvo que mujeres con estudios superiores tiene mayor prevalencia de uso de anticonceptivos y, finalmente, la edad en la 1ª relación sexual menor a los 17 años tiene mayor prevalencia llegando a la conclusión de que existe asociación positiva entre residir en área urbana, edad de primera relación sexual menor a 17 años, ser casada o conviviente y tener grado de instrucción superior y el uso de métodos anticonceptivos.¹⁵

ANTECEDENTES INTERNACIONALES

En el estudio realizado por Guerra M Ximena, Bedregal Paula, Weisstaub Gerardo, Caro M Patricia en el año 2017 en Chile. Mujeres chilenas en edad fértil: su estado nutricional y la asociación con actividad física y hábitos alimentarios, se realizó un estudio transversal dónde se evaluó a una población en estudio estuvo conformada por 1195 mujeres en edad fértil dónde se observó que la mayor prevalencia de malnutrición por exceso se presentó en mujeres entre 31 y 44 años, en aquellas con menor nivel educacional no expuestas a ambiente laboral y residentes en zona rural. Menos de 14% de la muestra consumía alimentos saludables en las porciones recomendadas y el consumo de frutas, verduras y cereales integrales fue significativamente mayor en el grupo con nivel educativo alto. En conclusión, los resultados refuerzan la relevancia de fomentar actividad física y alimentación saludable en las mujeres en edad fértil, priorizando los grupos más vulnerables, como aquellas con nivel educacional bajo, las que residen en zona rural, las mayores de 31 años y las expuestas a ambientes laborales.¹⁶

Morales-Ramírez, Dionicio, Sánchez-Hernández, Norma Alicia, & Martínez-Lara, Verónica en el año 2021 en México,). “El estilo de vida y su impacto sobre el estado nutricional en mujeres mexicanas: una aplicación del cuestionario FANTASTIC”, dónde se aplicó el cuestionario denominado *FANTASTIC* a una muestra de 390 mujeres adscritas a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) del Instituto Mexicano del Seguro Social situado en Ciudad Madero, Tamaulipas. Se elaboró un análisis de regresión múltiple para estudiar el impacto de variables como la edad, nivel de estudios, los antecedentes heredofamiliares, así como la medida estimada referente al estilo de vida sobre el estado nutricional, este último aproximado por el índice de masa corporal (IMC). Existe una relación, estadísticamente significativa, entre el estilo de vida y el estado nutricional, en donde las mujeres, que dicen llevar un estilo de vida saludable, presentan un IMC 12.86 % más bajo respecto de aquellas que no lo practican. Aunque, las cifras señalan que el 38.5 % de las mujeres se encuentra con problemas de sobrepeso y el 34.1 % en algún grado de obesidad.¹⁷

González Rodríguez Liliana Guadalupe, López Sobaler Ana M., Perea Sánchez José Miguel, Ortega Rosa M..en el año 2018 en su estudio titulado “Nutrición y Fertilidad”, dónde se realizó una revisión sobre los factores nutricionales que tienen mayor influencia en la fertilidad masculina y en la femenina dónde se concluyó que existen diversos factores asociados con la infertilidad, tales como la edad avanzada, la presencia de alteraciones estructurales en el aparato reproductor y enfermedades como la obesidad, la contaminación ambiental y el estilo de vida. En relación con la alimentación, se destaca que la ingesta en exceso de grasas saturadas, ácidos grasos trans y proteínas de origen animal podría tener un efecto perjudicial en la fertilidad, mientras que la ingesta de hidratos de carbono complejos, fibra, grasas monoinsaturadas y ácidos grasos omega-3 podría tener un efecto beneficioso. Asimismo, es indispensable tener un aporte adecuado de ácido fólico, B12, vitaminas A, D, C y E, calcio, hierro, zinc, selenio y yodo para evitar problemas en la fertilidad.¹⁸

González YC, Cabrera YOI, Castillo RP en el año 2022 en Cuba , su estudio denominado” Los estilos de vida de la mujer en edad fértil, un problema de la ciencia, la tecnología y la sociedad “desarrollaron un estudio a partir de las insuficiencias presentes en el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en los profesionales de la salud en la docencia médica, se argumenta y caracteriza los estilos de vida de la mujer en edad fértil como un problema de la ciencia, la tecnología y la sociedad, ponderando la aplicación del desarrollo científico-tecnológico contemporáneo en la formación integral en los residentes de Medicina General Integral dónde los estilos de vida erróneos influyen negativamente en la mujer en edad fértil, provocando orientaciones erradas hacia la vida como consecuencia de circunstancias agobiantes, como: estrés, trastornos psicológicos, malos hábitos en la alimentación, violencia intrafamiliar hasta una vida sexual inadecuada.¹⁹

González de la Cruz J, Trujillo-Hernández A. en el año 2022 en México , su estudio denominado “estilo de vida y salud reproductiva: factores de riesgo en mujeres” e utilizó como principal herramienta la recolección de datos a partir de encuestas orientadas al estilo de vida, alimentación, actividad física, niveles de estrés y salud reproductiva, dónde fue formulada en línea de acuerdo con los criterios de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Del total de la muestra se obtuvieron los siguientes resultados: 43% de las mujeres universitarias mencionaron ser sedentarias, 32% mencionaron tener sobrepeso y 7% obesidad. En materia de salud reproductiva, 78% reportó síntomas físicos y psicológicos característicos del síndrome premenstrual, 89% malestares durante el periodo menstrual, 12% señaló padecer de SOP y el 26% indicó tener familiares con problemas reproductivos. Asimismo, en lo que respecta a factores de riesgo, 55% señaló consumo de tabaco y 59% mencionó estar bajo niveles altos de estrés y mal manejo del estrés, el uso del cigarro y la contaminación afectan considerablemente el bienestar de las mujeres en materia de reproducción concluyendo que Incentivar a las mujeres a conocer más sobre el sistema reproductivo y los buenos hábitos en el estilo de vida puede coadyuvar a mejorar su bienestar físico y emocional.²⁰

Durante V, Gestación L, Del M, Román Gálvez R. en el año 2017 en Granada, España en su trabajo “Modificación de los estilos de vida durante la gestación” en una muestra de 463 gestantes sanas de cuatro provincias andaluzas. Se ha obtenido información sociodemográfica, obstétrica, antropométrica y de consumo de café y alcohol mediante cuestionario “ad hoc”. Se ha recogido información sobre los estilos de vida mediante cuestionarios validados: alimentación (PREDIMED), actividad física (IPAQ) y sueño (AIS). Los factores sociodemográficos afectan de forma desigual a los distintos estilos de vida y las mujeres de mayor edad se adhieren mejor a la dieta mediterránea, pero realizan menos actividad física; el menor nivel socioeconómico se asocia con menor adherencia a la dieta mediterránea, pero es factor protector frente al insomnio en el primer trimestre; la obesidad se asocia positivamente con la adherencia a la dieta mediterránea y con la actividad física, pero negativamente con el insomnio; el hecho de tener un hijo aumenta el riesgo de inactividad física y de insomnio ; finalmente el factor más fuertemente asociado abandono del hábito tabáquico, fue el hábito de la pareja.²¹

Plaza LBM, Quiroz V del RM, Vega ACR, Cabrera MCG, Rivadeneira FXM, Baque GCC. En su estudio denominado “Prevención y cuidados ginecológicos de la mujer en edad fértil” dónde los de factores de riesgo más reconocidos, se encuentra la anovulación crónica, la obesidad, la intolerancia a la glucosa y el uso prolongado de estrógenos. Llegando a la conclusión de que los

cuidados ginecológicos permiten a la mujer en edad fértil llevar un control de rutina, el cual le permitirá hacer énfasis en la prevención y el autocuidado; en la consulta pre concepcional, en la identificación de factores de riesgo y la preparación para el embarazo. Asimismo, le facilitará el hecho de desarrollar un control prenatal especializado, durante su embarazo, el cual le permitirá alcanzar los mejores resultados para ella y sus hijos.²²

En el estudio realizado por KP Soriano-Ortega E Carballo-Mondragón– AM Roque-Sánchez L Durán-Monterrosas A Kably-Ambe. En México en el año 2017 denominado “Percepción de la fertilidad en mujeres en edad reproductiva, según su edad” se obtuvieron 245 respuestas, pero se excluyeron dos por datos incompletos. La población de estudio se dividió en 7 grupos, según su edad. El 67% de quienes respondieron la encuesta fueron mujeres de 25-34 años, que abarcó el periodo más fértil. La escolaridad promedio fue de licenciatura y 55% eran casadas. El 69.1% de las encuestadas tenía un empleo y el nivel socioeconómico predominante fue clase media. El 65% de las mujeres utilizó algún método anticonceptivo; 91% de las mujeres desea tener hijos y 88.4% que no tienen se visualizan con ellos. Se consideró la mejor edad para iniciar la maternidad entre 25-29 años y una edad límite para poder embarazarse sin dificultad entre 30-34 años. A mejor y mayor conocimiento de la fertilidad femenina de las encuestadas, éstas consideraron la menor edad como la opción óptima para lograr el embarazo.²³

2.2 Bases teóricas

- **MEDICINA DE ESTILOS DE VIDA:**

Práctica basada en la evidencia, de asistir a individuos y familias en la adopción y mantención de conductas que mejoran la salud y calidad de vida, tales como alimentación saludable, realización de actividad física de manera periódica, sueño reparador, manejo del estrés, cese del uso de sustancias tóxicas y una sólida red de apoyo social.²⁴

- **NUTRICIÓN:**

Es el proceso por el cual el organismo ingiere, digiere, absorbe, transporta, utiliza y excreta las sustancias alimenticias, lo que permite el crecimiento adecuado, mantenimiento y reparación del organismo. A excepción de la ingesta del alimento, el resto del proceso es involuntario.²⁵

- **PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES:**

La prevención de la enfermedad es una estrategia de la Atención Primaria, que se hace efectiva en la atención integral de las personas y que considera al ser humano desde una perspectiva biopsicosocial e interrelaciona la promoción, la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social con las diferentes estructuras y niveles del sistema Nacional de Salud.²⁶

Se considera un enfoque de la atención sanitaria que se centra en evitar que las enfermedades ocurran en primer lugar, en lugar de tratar las enfermedades después de que estas se hayan desarrollado. Según la OMS, la Prevención se define como un conjunto de “Medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de

riesgo, sino también ase enfoca en detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida”²⁷

- **FERTILIDAD**

Capacidad para concebir un hijo que se produce cuando el óvulo se fusiona con un espermatozoide mientras se encuentra en una de las trompas de Falopio de la mujer.

La fertilidad en las mujeres tiene una pequeña relación con la edad que abarca desde los 40 años y el porcentaje de infertilidad alcanza el 50%, lo que finalmente concluye en la menopausia.²⁸

- **FAMILIA**

La familia es la primera forma de organización social y su existencia se comprueba en todos los pueblos y épocas de las que hay testimonio histórico. De modo que constituye una categoría de carácter universal. Se suele definir como célula básica de la sociedad y resulta evidente que sin su existencia sería inadmisibile la vida.²⁹

- **ACTIVIDAD FÍSICA**

Se hace referencia a actividad física a la acción de realizar cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que produzca un gasto energético mayor al existente en reposo.³⁰

- **TABAQUISMO**

El tabaquismo es considerado una enfermedad adictiva mantenida por una triple dependencia ya sea: química, psicológica y social. El tabaquismo está clasificado como una enfermedad crónica en la cual el fumador oscila entre múltiples períodos de remisión y recaída, que se debe a la potente adicción que genera la nicotina en el organismo.³¹

El consumo de tabaco en el sexo femenino está ligado a la aparición temprana de muchas enfermedades como la osteoporosis y la aparición temprana de la menopausia probablemente por el efecto tóxico del humo del cigarrillo sobre los folículos ováricos o por la interferencia con la liberación de la hormona luteinizante, no solo eso también se considera que las mujeres fumadoras que estén utilizando anticonceptivos orales presentan un mayor riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular entre otras.³²

- **ALCOHOLISMO**

El alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva, incurable y fatal, caracterizada por tolerancia, dependencia física, psicológica y por cambios orgánicos patológicos.³³

La ingestión de alcohol en las mujeres genera un mayor riesgo de desarrollar daños hepáticos, cerebrales y cardíacos. De hecho, en comparación con los hombres, las mujeres alcohólicas presentan tasas de mortalidad entre 50% y 100% más altas y las causas incluyen enfermedades cardíacas, derrame cerebral, cirrosis hepática, accidentes y suicidios.³³

- **CALIDAD DE SUEÑO:**

El sueño normal se define como un estado de disminución de la conciencia y de la posibilidad de reaccionar frente a los estímulos que nos rodean. Es un estado reversible -lo cual lo diferencia de otras condiciones patológicas como el coma, y se presenta con una periodicidad cercana a las 24 horas o “circadiana”.³⁴

La calidad de sueño, es tan importante ya que un tercio de la vida de un ser humano es ocupada en dormir, lo que demuestra que dormir es una actividad fisiológica imprescindible, interactuando y modulada por el balance psíquico y físico del individuo. Tanto es así que un mal dormir es la causa o bien exacerba un amplio rango de patologías: enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2 y síndrome metabólico, enfermedades psiquiátricas y cáncer.³⁵

- **ESTRÉS**

Es el estado de preocupación o tensión mental generado por una situación difícil. Todas las personas tienen un cierto grado de estrés, ya que se trata de una respuesta natural a las amenazas y a otros estímulos de nuestro cuerpo. Viene a ser la forma en que reaccionamos lo que marca el modo en que afecta a nuestro bienestar.³⁵

- **PERSONALIDAD**

Es la organización más compleja e integral de la vida subjetiva del ser humano que se puede conocer y comprender a través de aspectos concretos observables, tales como los hábitos, las costumbres, las conductas y las relaciones con otros. Se pueden observar las actividades que realizan las personas, las cosas que construyen, las relaciones que sostienen, pero lo que piensa, siente, cree o planea son conductas inobservables directamente.³⁶

2.3 Definiciones conceptuales

-MUJERES EN EDAD FÉRTIL:

Según la Organización Mundial de la Salud, la etapa reproductiva de la mujer se define entre los 15 a los 49 años de edad, dicha delimitación no incluye sin embargo la adolescencia temprana, donde se han reportado millones de casos de embarazos producto de diferentes circunstancias.³⁷

-ESTILO DE VIDA:

Según la OMS en 1986 definió los estilos de vida como una forma general de vida basada en la interacción entre las condiciones de vida en un sentido amplio y los patrones individuales de conducta determinados por factores socioculturales y características personales.³⁸

Se considera el estilo de vida como los hábitos, actitudes, conductas, actividades y decisiones de una persona, frente a diversas circunstancias en las que el ser humano se desarrolla en sociedad o mediante su quehacer diario y que son susceptibles de ser modificados. Un estilo de vida saludable está estrechamente relacionado con los siguientes aspectos: una dieta equilibrada, el mantenimiento del peso corporal, la práctica habitual de actividad física, y la abstención del consumo de alcohol y tabaco entre otros.³⁸

- **FACTORES SOCIOECONÓMICOS:**

Es el conjunto de variables que se constituye en un eje articulador de la interacción entre el poblador y su comunidad y toma forma sobre la base de la identificación de características de naturaleza social, que revelan aspectos del comportamiento social del individuo; de naturaleza económica, que evidencian aspectos vinculados con fuentes de ingresos del individuo; y de contenido educativo, que procura ir más allá del nivel socioeconómico. Cabe destacar que estas variables siguen un comportamiento que se da en forma más bien conjunta, antes que aislada.³⁹

- **FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS:**

Conjunto de características que definen estadísticamente a una población, o a un grupo dentro de ella, y que se utilizan para el estudio de sus patrones poblacionales y de su conformación colectiva. dicho de otro modo, son los rasgos mínimos de interés de una población estadística, tal y como los comprende la ciencia de la demografía.

Se trata de una fuente de información de interés en diferentes áreas del saber, ya sea con fines comerciales (como en el marketing y los estudios de consumo), científicos o investigativos (como en la salud pública y la psicología social), o incluso políticos (como en las encuestas de intención de voto). en todos estos casos, los datos demográficos alimentan las estadísticas y permiten conocer mejor la realidad de un conjunto de personas.⁴⁰

2.4 HIPÓTESIS

Existen factores sociodemográficos y económicos asociados significativamente a estilo de vida en mujeres de edad fértil (MEF) en el Centro de Salud Enrique Montenegro en el año 2024.

CAPÍTULO III **METODOLOGÍA**

3.1 Diseño

El estudio que se realizará es de carácter cuantitativo. observacional, analítico y transversal.

- Cuantitativo: Debido a que se recopilará la información en datos numéricos y se realizará análisis estadístico.
- Observacional: No se realizará intervención por parte del investigador, las variables de estudio solo serán observadas.
- Analítico: Porque se buscará identificar la asociación entre las variables (factores sociodemográficos-económicos y el estilo de vida).
- Transversal: Las variables serán medidas por única vez, en un tiempo y lugar determinado, sin seguimiento de la población.

3.2 Población y muestra

Población:

La población está conformada por las mujeres en edad fértil de 15 a 49 años, que acudan a los consultorios externos de Medicina del Centro de Salud Enrique Montenegro.

Muestra:

3.2.1 Tamaño de muestra:

Para el calculo muestral se utilizó el programa Open EPI Versión 03 utilizando como antecedente el estudio de Novak D y colaboradores,⁴¹ considerando un P1 de 0.48 y un P2 de 0.78, un intervalo de confianza del 95% y con un poder estadístico de 0,8. Obteniendo un tamaño mínimo muestral

de 94 pacientes.

Tamaño muestral: transversal, de cohorte, y ensayo clínico			
Nivel de significación de dos lados(1-alpha)			95
Potencia (1-beta,% probabilidad de detección)			80
Razón de tamaño de la muestra, Expuesto/No Expuesto			1
Porcentaje de No Expuestos positivos			48
Porcentaje de Expuestos positivos			78
Odds Ratio:			3.8
Razón de riesgo/prevalencia			1.6
Diferencia riesgo/prevalencia			30
	Kelsey	Fleiss	Fleiss con CC
Tamaño de la muestra - Expuestos	42	40	47
Tamaño de la muestra- No expuestos	42	40	47
Tamaño total de la muestra	84	80	94
Referencias			
Kelsey y otros, Métodos en Epidemiología Observacional 2da Edición, Tabla 12-15			
Fleiss, Métodos Estadísticos para Relaciones y Proporciones, fórmulas 3.18&, 3.19			
CC= corrección de continuidad			
Los resultados se redondean por el entero más cercano			
Imprima desde el menú del navegador o seleccione copiar y pegar a otros programas.			
Resultados de OpenEpi, versión 3, la calculadora de código abiertoSSCohort			

3.2.2 Tipo de muestreo:

Se usará el muestreo no probabilístico por conveniencia.

3.2.3 Criterios de selección de la muestra:

3.2.3.1 Criterios de inclusión:

- Mujeres atendidas en el consultorio de Medicina del C.S.E. Montenegro.
- Mujeres con edades comprendidas entre 18 a 49 años.
- Mujeres que acepten libremente ser parte de la investigación y brinden su consentimiento.

3.2.3.2 Criterios de exclusión:

- Mujeres con alguna limitación física o mental que les impida participa en el estudio.
- Mujeres que manifiesten antecedente de enfermedad crónica no transmisibles (Hipertensión arterial, diabetes mellitus, cáncer, enfermedad renal crónica, osteoartritis, accidente cerebro vascular)
- Mujeres cuyo cuestionario se encuentre incompleto.

3.3 Operacionalización de variables

VARIABLE	TIPO DE VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	NATURALEZA Y ESCALA DE MEDICIÓN	VALOR FINAL
FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS					
EDAD	Independiente	Número de años cumplidos al momento de la aplicación del instrumento.	Número de años indicado en el instrumento.	Cuantitativa Discreta Razón	• Años
GRADO DE INSTRUCCIÓN	Independiente	Grado de estudio alcanzado.	Grado de instrucción registrado en el instrumento	Cualitativa Ordinal Politómica	• Primaria • Secundaria • Superior no universitario • Superior universitario
ESTADO CIVIL	Independiente	Situación de las personas que por sus relaciones de parentesco y convivencia de acuerdo a las diversas formas de unión conyugal.	Estado civil descrito en el instrumento.	Cualitativa Nominal Politómica	• Soltera • Casada • Divorciada • Conviviente • Viuda
NÚMERO DE HIJOS	Independiente	Cantidad de hijos que tiene o tuvo la mujer.	# de hijos registrado en el instrumento.	Cuantitativa Ordinal Politómica	-----
FACTORES ECONÓMICOS					
TRABAJA	Independiente	Acción en la que la persona realiza un esfuerzo físico o intelectual para recibir un salario para la actividad que se encuentra realizando	Trabajo descrito en el instrumento.	Cualitativa Ordinal dicotómica	• Si • No

SALARIO QUE PERCIBE	Independiente	Cantidad de dinero que recibe en un mes.	Cantidad salarial registrado en el instrumento.	Cualitativa Ordinal, Razón	-----
SEGURO DE SALUD	Independiente	Contrato que cubre los gastos de salud de una persona	Tipo de Seguro descrito en el instrumento	Cualitativa Nominal Politómica	• SIS • ESSALUD • Privada • Fuerzas Armadas • Ninguno
ESTILO DE VIDA	Dependiente	Hábitos, actitudes, conductas, actividades y decisiones de una persona, frente a diversas circunstancias en las que el ser humano se desarrolla en sociedad o mediante su quehacer diario y que son susceptibles de ser modificados	Estilo de vida será medida a través del “Test Fantástico” cuyas dimensiones son: familia, actividad física- asociatividad, nutrición- alimentación, tabaco- dependencia, alcohol, sueño- estrés, trabajo- personalidad, introspección, control de salud-sexualidad y otros.	Cualitativa Nominal Politómica	• Zona de peligro (0-46 puntos) • Algo bajo-podrías mejorar (47-72 puntos) • Adecuado-estas bien (73-84 puntos) • Buen trabajo- estas en el camino correcto (85-102 puntos) • Felicitaciones-tienes un estilo de vida fantástico (103-120puntos)

3.4 Técnicas de recolección de datos. Instrumentos

Se solicitará evaluación y aprobación del presente proyecto, dirigido a la directora general de DIRIS LIMA CENTRO y del Centro de Salud Enrique Montenegro en San Juan de Lurigancho, previa a la ejecución de la investigación.

La técnica de recolección de datos a utilizar será la entrevista, utilizando como instrumento un cuestionario auto aplicado.

El cuestionario consistirá en dos secciones: la primera sección incluirá los datos sociodemográficos y económicos y la segunda sección: evaluará la variable “estilo de vida” mediante el “test FANTÁSTICO” adaptado y validado a la población peruana por Villar López, M. et al. en el 2016.⁴²

El cuestionario FANTASTICO es un instrumento diseñado en el Departamento de Medicina Familiar de la Universidad McMaster de Hamilton, Ontario (Canadá), considerado una herramienta de apoyo a los profesionales en el contexto de promoción de la salud y prevención de la enfermedad que permite identificar y medir los estilos de vida de una población general.⁴³ Este instrumento consta de 10 dominios los cuales son: Familia-amigos, Actividad física-asociatividad, Nutrición – alimentación, Tabaco- dependencia, Alcohol, Sueño-estrés, Trabajo y personalidad, Introspección, Control de salud, Sexualidad y Otros. Considerando puntajes entre 0 a 120, siendo los resultados establecidos en las siguientes categorías: estas en zona de peligro (0-46 puntos), algo bajo-podrías mejorar (47-72 puntos), adecuado-esas bien (73-84 puntos), buen trabajo- estas en el camino correcto (85-102 puntos), felicitaciones-tienes un estilo de vida fantástico (103-120 puntos); considerando criterios de confiabilidad positivos como alfa de Cronbach de 0.778, prueba de Barlett $p < 0.001$ y Kaiser- Meyer-Olkin 0.804.⁴²

El test FANTÁSTICO ha sido utilizado en múltiples estudios internacionales como en el de Salinas Boshell, Juan Sebastián titulado “Evaluación de los estilos de vida de población adulta de la localidad de Kennedy de Bogotá”⁴⁴; también en un estudio realizado por Rivas Vega,B; Silva Figueroa A; Morales Lazcano M denominado “Estilo de vida y riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en adultos jóvenes”⁴⁵ y Rodríguez-Núñez JL, Maygualema-León BM. en su investigación de “Estilos de vida y riesgos en la salud de los trabajadores de la construcción mediante el “test fantástico”⁴⁶. También ha sido utilizada en estudios peruanos como el de Castillo (2024)⁴⁷ y Vilela-Córdova (2024) en estudiantes peruanos⁴⁸; De la Cruz Inga (2024) en población trans⁴⁹, Ibazeta (2023) en pacientes de medicina interna⁵⁰ y Rodríguez Sánchez (2023) en población general⁵¹, apoyando la evidencia de la validez de dicho instrumento.

Los datos serán recolectados mediante encuestas impresas, posterior a la firma del Consentimiento informado. Asimismo, se realizará una prueba piloto para comprobar la comprensión y el tiempo de llenado del cuestionario. Se estima que el tiempo aproximado del llenado será de 15-20 minutos.

3.5 Técnicas para el procesamiento de la información

La información recopilada durante la recolección de datos será tabulada usando el programa Excel; el análisis de datos será realizado a través del programa estadístico SPSS en la versión 25.0, dónde se realizará la medida de las frecuencias y porcentajes del estudio. En este estudio se usará como medida de asociación RP cruda y ajustada, utilizada un IC 95%. Todas las pruebas de hipótesis utilizaran un valor de significancia de $p < 0.05$.

3.6 Aspectos éticos

Este proyecto de investigación mantendrá el principio de confidencialidad en todo momento, los datos personales de los participantes no serán expuestos, ya que toda la información recopilada será de manera anónima, sólo con la finalidad de investigación. Este estudio cuenta con la aprobación del comité de ética de la FAMURP; cumpliendo de esta manera los principios dados por el informe de Belmont y la declaración de Helsinki.

Se solicitará a cada participante de este estudio la autorización expresa a través de la firma de un consentimiento informado, previa encuesta. Finalmente, también se solicitará el permiso del Centro de Salud Enrique Montenegro en San Juan de Lurigancho para poder llevar a cabo la realización de este estudio.

CAPÍTULO IV

RECURSOS Y CRONOGRAMA

4.1 Recursos

RECURSOS	DESCRIPCIÓN
Recursos Humanos	● Investigadores (a su vez encuestadores) ● Asesora ● Personal sanitario de apoyo del centro de salud ● Estadístico para tabulación y obtención de resultados estadísticos.
Recursos Materiales	● Papel (encuestas, consentimiento informado, anillado, empastado) ● Laptop ● Lapiceros
Recursos Financieros	● Transporte ● Refrigerios

4.2 Cronograma

Actividades	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Herrera-Cuenca M. Mujeres en edad fértil: Etapa crucial en la vida para el desarrollo óptimo de las futuras generaciones [Internet]. Anales de nutrición .Org.ve. 2018 [citado el 15 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://www.analesdenutricion.org.ve/ediciones/2017/2/art-5>

2. World Health Organization Reproductive Health Indicators Reproductive Health and Research Guidelines for their generation, interpretation and analysis for global monitoring. Geneva, Switzerland 2006. Acceso a través de URL: <http://www.ossyr.org.ar/pdf/bibliografia/2.22>

3. Morales-Ramírez, Sánchez-Hernández, Martínez-Lara. El estilo de vida y su impacto sobre el estado nutricional en mujeres mexicanas: una aplicación del cuestionario FANTASTIC. [citado el 15 de octubre de 2024]; Disponible en: <https://www.ciad.mx/estudiosociales/index.php/es/article/view/835/527>

4. Martínez Abreu Janet, Martínez Abreu Judit, González Ponce Grisela. Salud de la mujer en edad fértil, su preparación para la maternidad y la familia: their training for childbearing and family. Rev. Med. Electrónica. [Internet]. 2018 Abr [citado 2023 Oct 26] ; 40(2): 246-248. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242018000200001&lng=es.

5. INEI. Instituto Nacional de Estadística e Informática [Internet]. Gob.pe. [citado el 4 de noviembre de 2023]. Disponible en: <https://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/en-el-peru-mas-de-ocho-millones-777-mil-mujeres-son-madres-13575/>

6. PERÚ Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI [Internet]. Gob.pe. [citado el 4 de noviembre de 2023]. Disponible en: <https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/ocupacion-y-vivienda/>

7. Vega C. El impacto del desempleo en la salud: cómo afecta y cómo enfrentarlo [Internet]. Aprende Economía. 2023 [citado el 4 de noviembre de 2023]. Disponible en: <https://aprendeconomia.info/como-afecta-el-desempleo-en-la-salud-de-las-personas>

8. Hernández Martínez Liety. Estilos y calidad de vida hacia una maternidad saludable. Rev Ciencias Médicas [Internet]. 2020 Jun [citado 2023 Nov 04] ; 24(3): e4432. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-31942020000300005&lng=es. Epub 01-Mayo-2020.

9. INEI. Instituto Nacional de Estadística e Informática [Internet]. Gob.pe. [citado el 4 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/el-8-de-marzo-cerca-de-17-millones-de-mujeres-conmemoran-su-dia-en-el-peru -14282/>

10. Álvarez C Luz S. Los estilos de vida en salud: del individuo al contexto. Rev. Fac. Nac. Salud Pública [Internet]. Abril de 2012 [consultado el 4 de octubre de 2024]; 30(1): 95-101. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-386X2012000100011&lng=en.
11. Morales-Ramírez D, Sánchez-Hernández NA, Martínez-Lara V. El estilo de vida y su impacto sobre el estado nutricional en mujeres mexicanas: una aplicación del cuestionario FANTASTIC. *Estud Soc Rev Aliment Contemp Desarro Reg* [Internet]. 2020 [citado el 4 de octubre de 2024];30(55). Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2395-91692020000100102
12. Juárez AFC, Gutiérrez-Aguado A, Espinoza R, Cruz-Vargas JADL. Estilos de vida en mujeres de 18 a 49 años con sobrepeso y obesidad del Perú: análisis de la ENDES 2018. *Revista Peruana de Medicina Integrativa* [Internet]. 2022 Dec 14 [citado 2023 Jul 4];7(4). Disponible en: <https://rpmi.pe/index.php/rpmi/article/view/691/728>
13. Garcia Z, Shiomara T. Factores sociodemográficos y acciones de prevención y promoción asociado al comportamiento de la salud: estilos de vida de la mujer adulta joven. *Pueblo joven Miramar Alto, sector Chimbote*, 2019. Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote [Internet]. 2022 setiembre. 20 [citado 2023 Nov 7]; Disponible en: <https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/4834735>
14. Quillas Benites Ruth Keyla, Vásquez Valencia Cesar, Cuba Fuentes María Sofía. Promoción de cambios de comportamiento hacia estilos de vida saludable en la consulta ambulatoria. *Acta méd. Peru* [Internet]. 2017 Abr [citado 2023 Nov 07]; 34(2): 126-131. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-59172017000200008&lng=es.
15. Meléndez-Asipali Josué A., Espinoza Rubén, Rivadeneyra-Romero Rosa, Vela-Ruiz José M., De La Cruz-Vargas Jhony A.. Factores asociados al uso de métodos anticonceptivos en mujeres en edad fértil de 15 a 49 años según encuesta demográfica en Perú. *Rev. Cuerpo Med. HNAAA* [Internet]. 2022 Abr [citado 2023 Nov 07]; 15(2): 180-184. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2227-47312022000200003&lng=es.
16. Guerra M Ximena, Bedregal Paula, Weisstaub Gerardo, Caro M Patricia. Mujeres chilenas en edad fértil: su estado nutricional y la asociación con actividad física y hábitos alimentarios. *Rev. méd. Chile* [Internet]. 2017 Feb [citado 2023 Nov 06]; 145(2): 201-208. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872017000200008&lng=es. <http://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872017000200008>.
17. Morales-Ramírez, Dionicio, Sánchez-Hernández, Norma Alicia, & Martínez-Lara, Verónica. (2020). El estilo de vida y su impacto sobre el estado nutricional en mujeres mexicanas: una aplicación del cuestionario FANTASTIC. *Estudios sociales. Revista de alimentación contemporánea y desarrollo regional*, 30(55), e20835. Epub 06 de diciembre de 2021. Disponible en : <https://doi.org/10.24836/es.v30i55.835>

18. González Rodríguez Liliana Guadalupe, López Sobaler Ana M., Perea Sánchez José Miguel, Ortega Rosa M.. Nutrición y fertilidad. Nutr. Hosp. [Internet]. 2018 [citado 2023 Nov 07]; 35(spe6): 7-10. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112018001200003&lng=es. Epub 06-Jul-2020. Disponible en: <https://dx.doi.org/10.20960/nh.2279>.
19. González YC, Cabrera YOI, Castillo RP. LOS ESTILOS DE VIDA DE LA MUJER EN EDAD FERTIL, UN PROBLEMA DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA SOCIEDAD. Didáctica y Educación ISSN 2224-2643 [Internet]. 2022 Jan 31 [citado 2023 Nov 7];13(1):318–40. Disponible en: <https://revistas.ult.edu.cu/index.php/didascalía/article/view/1322/1302>
20. González de la Cruz J, Trujillo-Hernández A. ESTILO DE VIDA Y SALUD REPRODUCTIVA: FACTORES DE RIESGO EN MUJERES. RDI [Internet]. 14 de noviembre de 2022 [citado 7 de noviembre de 2023];8(24):25-6. Disponible en: <http://rd.buap.mx/ojs-dm/index.php/rdicuap/article/view/982>
21. De Los M, De E, Durante V, Gestación L, Del M, Román Gálvez R. TESIS DOCTORAL “Modificación de los estilos de vida durante la gestación” [Internet]. 2017 [citado 2023 Nov 7]. Disponible en: <https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/50921/2887366x.pdf?sequence=4&isAllowed=y>
22. Plaza LBM, Quiroz V del RM, Vega ACR, Cabrera MCG, Rivadeneira FXM, Baque GCC. Prevención y cuidados ginecológicos de la mujer en edad fértil. RECIAMUC [Internet]. 2019 Jul 1 [citado 2023 Noviembre 3];3(3):1303–22. Disponible en: <https://reciamuc.com/index.php/RECIAMUC/article/view/383/585>
23. Soriano-Ortega KP, Carballo-Mondragón E, Roque-Sánchez AM, Durán-Monterrosas L, Kably-Ambe A, Soriano-Ortega KP, et al. Percepción de la fertilidad en mujeres en edad reproductiva, según su edad. Ginecología y obstetricia de México [Internet]. 2017;85(6):364–73. Disponible en : https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0300-90412017000600364.
24. Izcue J, Cordero MJ, Plaza M, Correa P, Hidalgo A. ¿Qué es la Medicina del Estilo de Vida y por qué la necesitamos? Rev médica Clín Las Condes [Internet]. 2021;32(4):391–9. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.rmcl.2021.01.010>.
25. Corio Andújar R, Arbonés Fincias L. Nutrición y salud. Semergen [Internet]. 2009;35(9):443–9. Disponible en: [http://dx.doi.org/10.1016/s1138-3593\(09\)72843-6](http://dx.doi.org/10.1016/s1138-3593(09)72843-6)
26. Escalante PR. Curso de Gestión Local de Salud para Técnicos del Primer Nivel de Atención , "Prevención de la enfermedad" [Internet]. Gub.uy. 2004 [citado el 16 de octubre de 2024]. Disponible en: https://montevideo.gub.uy/sites/default/files/concurso/materiales/anexo_07_-_niveles_de_preencion.pdf
27. Vignolo, Julio. Niveles de Atención, de prevención y atención primaria de la salud. Scielo

[Internet].2011 Marzo.30 [citado 22 Ago 2024] XXXIII (1):11-14.Disponible en:
<http://www.scielo.edu.uy/pdf/ami/v33n1/v33n1a03.pdf>

28. Martínez Vasallo Haydee Maité. La familia: una visión interdisciplinaria. Rev.Med.Electrón. [Internet]. 2015 Oct [citado 2024 Ago 23] ; 37(5): 523-534. Disponible en:
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242015000500011&lng=es.

29.Escalante Yolanda. Actividad física, ejercicio físico y condición física en el ámbito de la salud pública. Rev. Esp. Salud Publica [Internet]. 2011 Ago [citado 2024 Ago 23] ; 85(4): 325-328. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272011000400001&lng=es.

30. Tabaquismo. Archivo argentina. pediatría. [Internet]. 2005 Oct [citado 2024 Ago 27] ; 103(5): 464-475. Disponible en:
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-00752005000500014&lng=es.

31. Becoña Elisardo, Vázquez Fernando L.. Las mujeres y el tabaco: características ligadas al género. Rev. Esp. Salud Publica [Internet]. 2000 Feb [citado 2024 Ago 27] ; 74(1): 00-00. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272000000100003&lng=es.

32. Borrero Benítez F, Fajardo Bernal J, Genechea Benítez M, , Méndez Torres VM Alcoholismo y sociedad. Revista Información Científica [Internet]. 2012;75(3): Disponible en : <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=551757270028>.

33. Del Carmen Míguez María, Permuy Beatriz. Características del alcoholismo en mujeres. rev.fac.med. [Internet]. marzo de 2017 [consultado el 27 de agosto de 2024]; 65(1): 15-22. Disponible en:
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S012000112017000100015&lng=en.
<https://doi.org/10.15446/revfacmed.v65n1.57482> .

34. Fabres L, Moya P. Sueño: conceptos generales y su relación con la calidad de vida. Rev. médica Clín Las Condes [Internet]. 2021;32(5):527–34. Disponible en:
<http://dx.doi.org/10.1016/j.rmcl.2021.09.001>

35. Organización Mundial de la Salud [Internet]. Estrés [citado el 27 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/stress>

36. Tintaya Condori P. Psicología y Personalidad. Revista de Psicología [Internet]. 2019 [citado el 27 de agosto de 2024];(21):115–34. Disponible en:
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2223-30322019000100009

37. Mujeres en edad fértil: Etapa crucial en la vida para el desarrollo óptimo de las futuras generaciones [Internet]. Bvsalud.org. [citado el 27 de agosto de 2024]. Disponible en:
<https://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/10/1023558/art-5.pdf>

38. Estilos de Vida [Internet]. Atención Primaria. 2021 [citado el 27 de agosto de 2024].

Disponible en: <https://www.comunidad.madrid/hospital/atencionprimaria/ciudadanos/estilos-vida>.

39. Ajrota KAO. Relación entre los factores socioeconómicos y actitud hacia la minería en pobladores del distrito de Torata, provincia mariscal nieto, Moquegua, Perú, 2022 [Internet]. 2022 [citado el 17 de octubre de 2024].

Disponible en: https://1library.co/article/factores-socioecon%C3%B3micos-bases-te%C3%B3ricas.qo5970em#google_vignette

40. Gómez Cruz, Z., Landeros Ramírez, P., Romero Velarde, Enrique., Troyo Sanromán, R., (2016) Estilos de vida y riesgos para la salud en una población universitaria, Revista de Salud Pública y Nutrición, 15(2), 9-14 [Internet]. Medigraphic.com. [citado el 16 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/revsalpubnut/spn-2016/spn162c.pdf>

41. Novak D, Lovro Š, Antala B, Emeljanovas A, Mieziene B, Milanović I, Radisavljević-Janić S. Asociaciones entre el estatus socioeconómico y los factores de estilo de vida en adolescentes europeos: un estudio de base poblacional. Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae. Sciendo, 2017;57(2): 111-124. <https://doi.org/10.1515/afepuc-2017-0011>

42. Villar López M, Ballinas Sueldo Y, Gutiérrez C, Angulo-Bazán Y. Análisis de la confiabilidad del test Fantástico para medir Estilos de vida saludables en trabajadores evaluados por el Programa “Reforma de Vida” del Seguro Social de Salud (Essalud). Revista Peruana de Medicina Integrativa. 2016;1(2):17-26.

Disponible en :

<https://repositorio.essalud.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12959/3983/An%C3%A1lisis%20de%20la%20confiabilidad%20del%20test%20Fant%C3%A1stico%20para%20medir%20Estilos%20de%20vida.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

43. Wilson DM, Ciliska D. Life-style assessment: Development and use of the FANTASTIC checklist. Can Fam Physician 1984; 30:1527- 32

Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/817/81742138002.pdf>

44. Salinas Boshell, J, Daza Ramírez, J Evaluación de los estilos de vida de población adulta mayor de la localidad de Kennedy de Bogotá. [Internet]. Bogotá: Fundación Universitaria del Área Andina; 2020 [citado: 2024, diciembre] 18 páginas Disponible en:

<https://digitk.areandina.edu.co/entities/publication/371c21b5-e5fe-4142-84e4-7e0d208dc427>

45. Vega BR, Figueroa AS, Lazcano MÁM. Estilo de vida y riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en adultos jóvenes [Internet]. Wordpress.com. Vol15 (4)[citado el 5 de diciembre de 2024]. Disponible en: https://iydt.wordpress.com/wp-content/uploads/2023/11/4_67_estilo-de-vida-y-riesgo-de-desarrollar-diabetes-mellitus-tipo-2-en-adultos-jovenes.pdf

46. Rodríguez-Núñez JL, Maygualema-León BM. Estilos de vida y riesgos en la salud de los

trabajadores de la construcción mediante el “test fantástico”. Polo del Conocimiento [Internet]. 2021 [citado el 5 de diciembre de 2024];6(10):584–605. Disponible en: <https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/3226>

47.Castillo Contreras M, Velásquez Paz R. Factores Sociodemográficos y Estilos de Vida en estudiantes de una universidad pública del Perú. [Trujillo]: Universidad Nacional de Trujillo; 2024.Disponible en : <https://dspace.unitru.edu.pe/server/api/core/bitstreams/17886353-6454-4ad5-91ce-64d37499ce3f/content>

48.Vilela-Córdova Y Arroyo Sanchez A. View of Associated factors with inadequate lifestyle in medicine students in a Peruvian university. <http://revistas.urp.edu.pe/index.php/RFMH/article/view/6532/10931> [Internet]. 2024 [citado el 5 de diciembre de 2024];24(4):101–11. Disponible en: <http://revistas.urp.edu.pe/index.php/RFMH/article/view/6532/10931>

49.De La Cruz Inga LM. UNIVERSIDAD RICARDO PALMA [Internet]. [Lima-Perú]: <https://repositorio.urp.edu.pe/server/api/core/bitstreams/df9c4852-8b18-410a-819e-39cd5c3c67d4/content>; 2024 [citado el 5 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://repositorio.urp.edu.pe/server/api/core/bitstreams/df9c4852-8b18-410a-819e-39cd5c3c67d4/content>

50. Ibazeta Valdivieso AG, Pérriggo JC. Estilos de vida en pacien-tes con enfermedades crónicas no transmisibles atendidos en un hospital peruano. Rev Peru Med Integrativa. 2023; 8(2):83-89 Disponible en: <https://rpmi.pe/index.php/rpmi/article/view/728/791>

51. Rodriguez Sanchez, A ,Solis Rueda, K “Estilos de vida y estrés en personas con hipertensión arterial en la Comunidad “Brisas de Santa Rosa Lima” en San Martin de Porres Lima - Perú, 2023. [Lima]: Universidad Cesar Vallejo; 2023. Disponible en: <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/130715>

1. Matriz de consistencia

PROBLEMA	OBJETIVO	HIPOTESIS	MÉTODO DE ESTUDIO	VARIABLES	POBLACIÓN Y MUESTRA
¿Cuáles son los factores asociados a los estilos de vida en las mujeres de edad fértil en el Centro de Salud Enrique Montenegro 2024?	OG: Determinar los factores asociados a estilos de vida en mujeres de edad fértil (MEF) en el Centro de Salud Enrique Montenegro 2024. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: - Identificar las características sociodemográficas de las MEF en el CSM, en diciembre 2024. - Identificar la frecuencia de los niveles de estilo de vida en MEF en el Centro de Salud Montenegro en diciembre 2024. - Determinar la asociación entre los factores sociodemográficos y el estilo de vida en MEF. en el Centro de Salud	Ha: Existen factores asociados significativamente a estilos de vida en mujeres de edad fértil (MEF) en el Centro de Salud Enrique Montenegro 2024.	Es un estudio transversal, observacional, analítico y cuantitativo.	Independiente: Factores asociados Dependiente: estilos de vida	Mujeres en edad fértil en el Centro de Salud Enrique Montenegro 2024.
				Independiente: Conocimientos Dependiente: característica sociodemográfica	El tamaño de muestra de MEF del Centro de Salud Enrique Montenegro 2024.
				Independiente: Conocimientos Dependiente: Socioeconómico	El tamaño de muestra de MEF del Centro de Salud Enrique Montenegro 2024.
				Independiente: Conocimientos Dependiente: Actividad física	Mujeres en edad fértil en el Centro de Salud Enrique Montenegro 2024.

	Montenegro en diciembre 2024. • Determinar la asociación entre los factores económicos y el estilo de vida en MEF en diciembre 2024.				
--	---	--	--	--	--

2. Instrumentos de recolección de datos

INSTRUMENTO

CUESTIONARIO SOBRE FACTORES ASOCIADOS A ESTILO DE VIDA EN MUJERES EN EDAD FÉRTIL EN EL CENTRO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, 2024.

Instrucciones.

La encuesta que tiene en sus manos es parte de una investigación y cuenta con la aprobación de un Comité de Ética e Investigación. Su participación en este estudio es voluntaria, con el llenado de la encuesta entendemos que brinda su consentimiento para participar en la investigación.

Los datos proporcionados son confidenciales y anónimos. Los resultados de esta investigación serán publicados en una revista científica. Responda con “X” las preguntas de marcar.

PRIMERA SECCIÓN: DATOS GENERALES

1. **Edad:** _____ años
2. **Estado civil:** Soltera () Casada () Viuda () Divorciada ()
3. **Nivel educativo:**
Primaria completa () Secundaria incompleta () Educación incompleta superior ()
Educación completa superior ()
4. **Actualmente Ud.:** Tiene pareja () No tiene pareja ()
5. **Con quien vive usted:** Sola () Con mi pareja () Padres, hermanos ()
Amigos () Otros familiares ()
6. **Para solventar los gastos diarios:** Recibe dinero de sus familiares () Trabaja () Trabaja y recibe dinero de sus familiares ()
7. **Su ingreso salarial mensual es de:** menos de 500 soles () entre 500 y 900 soles ()
más de 1000 soles ()
8. **¿Tiene hijos?** SI () NO () **¿Cuántos hijos tiene?** _____
9. **¿Le han diagnosticado previamente alguna enfermedad?** SI () NO () **¿Cuál?**
Hipertensión arterial () diabetes mellitus () cáncer () enfermedad renal crónica ()
osteoartritis () accidente cerebro vascular () Otra: _____
10. **¿Cuenta con algún seguro de Salud?:** SI () No () **¿Cuál?** SIS () Essalud ()
Privado () Otro: _____
11. **¿Usted come todos los días, el mismo número de comidas?** SI () No ()
12. **¿Usted en qué lugar donde se alimenta?:** Casa donde vive () Pensión () Comedor universitario () Vendedores ambulantes () Otros: _____
13. **¿Realiza alguna actividad física?** Si () No () **¿Cuál?** _____

SEGUNDA SECCIÓN: CUESTIONARIO FANTÁSTICO ESTILOS DE VIDA

	ESTILO DE VIDA	CASI NUNCA	A VECES	SIEMPRE
Familia, amigos	Tengo con quien hablar de las cosas que son importantes para mí			
	Doy y recibo cariño			
	Me cuesta decir buenos días, perdón, gracias o lo siento.			
Actividad física, asociatividad	Soy integrante activo de grupos de apoyo a la salud o sociales.			
	Realizo actividad física por 30 min.			
	Camino al menos 30 min diariamente			
Nutrición y alimentación	Como dos porciones de frutas y tres de verduras			
	A menudo consumo mucha azúcar, sal, comida chatarra, o grasas			
	Estoy pasado en mi peso ideal			
Tabaco, dependencia	Fumo cigarrillos			
	Cigarros fumados por día			
	Uso excesivamente medicamentos sin prescripción médica o me automedico			
Alcohol	Número promedio de tragos a la semana			
	Bebo 8 vasos con agua cada día			
	Bebo té, café, cola, gaseosa			
Sueño, estrés	Duermo bien y me siento descansado			
	Me siento capaz de manejar el estrés o la tensión de mi vida			
	Me relajo y disfruto mi tiempo libre			
Trabajo y personalidad	Parece que ando acelerado			
	Me siento enojado o agresivo			
	Me siento contento con mi trabajo y actividades			
Introspección	Soy un pensador positivo			
	Me siento tenso o abrumado			
	Me siento deprimido o triste			
Control de salud, sexualidad	Me realizo controles de salud en forma periódica			
	Converso con mi pareja o familia aspectos de sexualidad			

	En mi conducta sexual me preocupo del autocuidado y del cuidado de mi pareja			
Otros	Como peatón, pasajero del transporte público, sigo las reglas.			
	Uso cinturón de seguridad			
	Tengo claro el objetivo de mi vida.			

Gracias por su participación.

3. Consentimiento informado

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE INVESTIGACIÓN

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participantes.

La presente investigación es conducida por Nicole Camila Palomino Rivera de la Universidad Ricardo Palma. La meta de este estudio es determinar los factores asociados a estilos de vida en mujeres de edad fértil que acudan al Centro de Salud Enrique Montenegro. Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá completar una encuesta. Esto tomará aproximadamente 15-20 minutos de su tiempo. La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación.

Sus respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas.

Una vez transcritas las entrevistas se destruirán.

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma.

Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parece incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.

Desde ya le agradecemos su participación.

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Nicole Camila Palomino Rivera, he sido informada de que la meta de este estudio, y me indicaron también que tendré que responder cuestionarios, lo cual tomará aproximadamente 10 minutos. Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a Nicole Camila Palomino Rivera al teléfono 948391802.

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo contactar a Nicole Camila Palomino Rivera y al teléfono anteriormente mencionado.

SI ACEPTO _____

NO ACEPTO _____

FIRMA